硝苯地平

知识类别：药品说明书
资料来源：中国医药信息查询平台（经审核认证词条，逐字转载）
来源 URL：https://www.dayi.org.cn/drug/1151977.html
获取日期：2026-10-20

以下为逐字转载的原文内容：

硝苯地平
硝苯地平，西药名。常用剂型为片剂、胶囊剂、滴丸剂。为钙通道阻滞剂。用于心绞痛：变异型心绞痛；不稳定型心绞痛；慢性稳定型心绞痛。高血压（单独或与其它降压药合用）。 该药品医保类型有：硝苯地平片、硝苯地平控释片、硝苯地平缓释片、硝苯地平缓释片（Ⅰ）、硝苯地平缓释片（Ⅱ）、硝苯地平缓释片（Ⅲ）、硝苯地平缓释胶囊、硝苯地平软胶囊为医保甲类。
英文名称
汉语拼音
药品类型
处方类型
医保类型
参考价格
成分
性状
适应症
规格
用法用量
临床应用及指南
不良反应
禁忌
注意事项
药物相互作用
药理作用
毒理作用
药代动力学
贮藏方法
有效期
执行标准
成分
本品主要成份为硝苯地平。
性状
硝苯地平片：糖衣片，除去包衣后显黄色。
硝苯地平控释片：圆形双凸的坚硬玫瑰红色薄膜衣片。
硝苯地平缓释片：薄膜衣片，除去薄膜衣后显黄色。
硝苯地平缓释片（Ⅰ）：薄膜衣片，除去薄膜衣显黄色。
硝苯地平缓释片（Ⅱ）：黄色片。

硝苯地平缓释片（Ⅲ）：薄膜衣片，除去包衣后显黄色。
硝苯地平缓释胶囊：内容物为褐色微粒。
硝苯地平软胶囊：内容物为黄色粘稠液体。
硝苯地平滴丸：薄膜衣滴丸，除去薄膜衣后显黄色。
适应症
本品用于心绞痛：变异型心绞痛；不稳定型心绞痛；慢性稳定型心绞痛。高血压（单独或与其它降压药合用）。
规格
硝苯地平片、硝苯地平软胶囊：5mg；10mg。
硝苯地平控释片：30mg；60mg。
硝苯地平缓释片：10mg；20mg。
硝苯地平缓释片：（Ⅰ）10mg。
硝苯地平缓释片（Ⅱ）、硝苯地平缓释胶囊：20mg。
硝苯地平缓释片（Ⅲ）：30mg。
硝苯地平滴丸：5mg。
用法用量
本品不同剂型、不同规格的用法用量可能存在差异，请阅读具体药物说明书使用，或遵医嘱。
硝苯地平片、硝苯地平软胶囊、硝苯地平滴丸：
口服。
1、硝苯地平的剂量应视患者的耐受性和对心绞痛的控制情况逐渐调整。过量服用硝苯地平可导致低血压。
2、从小剂量开始服用，一般起始剂量10mg/次，一日3次口服；常用的维持剂量为口服10-20mg/次，一日3次。部分有明显冠脉痉挛的患者，可用至20-30mg/次，一日3-4次。最大剂量不宜超过120mg/日。如果病情紧急，可嚼碎服或舌下含服10mg/次，根据患者对药物的反应，决定再次给药。
3、通常调整剂量需7-14天。如果患者症状明显，病情紧急，剂量调整期可缩短。根据患者对药物的反应、发作的频率和舌下含化硝酸甘油的剂量，可在3天内将硝苯地平的用量从10-20mg调至30mg/次，一日3次。
4、在严格监测下的住院患者，可根据心绞痛或缺血性心律失常的控制情况，每隔4-6小时增加1次，每次10mg。
硝苯地平控释片：
1、治疗时应尽可能按个体情况用药。依据患者的临床情况，给予不同的基础用药剂量。
2、除非特殊医嘱，成年人推荐下列剂量：
（1）高血压：一次30mg或60mg，一日1次。
（2）冠心病：慢性稳定型心绞痛(劳累性心绞痛)，一次30mg或60mg，一日1次
（3）通常治疗的初始剂量为每日30mg。
3、与CYP3A4抑制剂或CYP3A4诱导剂合用时可能需调整硝苯地平的剂量或不使用硝苯地平（见【药物相互作用】）。
4、疗程：用药时间应由医生决定。
5、用药方法：通常整片药片用少量液体吞服，服药时间不受就餐时间的限制。应避免食用葡萄柚汁（见【药物相互作用】）。
6、特殊人群：
肝功能损害的患者：基于ChildPugh评分的轻度、中度或重度肝功能损害患者用药应仔细监控，可能需要减少剂量。未在重度肝功能损害患者中研究硝苯地平的药代动力学（见【注意事项】和【药代动力学】）。

硝苯地平缓释片：
1、治疗时应尽可能按个体情况用药。依据患者的临床情况，给予不同的基础用药剂量。
2、除非特殊医嘱，成年人推荐下列剂量：
（1）高血压：一次30mg或60mg，一日1次。
（2）冠心病：慢性稳定型心绞痛(劳累性心绞痛)，一次30mg或60mg，一日1次
（3）通常治疗的初始剂量为每日30mg。
3、与CYP3A4抑制剂或CYP3A4诱导剂合用时可能需调整硝苯地平的剂量或不使用硝苯地平（见【药物相互作用】）。
4、疗程：用药时间应由医生决定。
5、用药方法：通常整片药片用少量液体吞服，服药时间不受就餐时间的限制。应避免食用葡萄柚汁（见【药物相互作用】）。
6、特殊人群：
肝功能损害的患者：基于ChildPugh评分的轻度、中度或重度肝功能损害患者用药应仔细监控，可能需要减少剂量。未在重度肝功能损害患者中研究硝苯地平的药代动力学（见【注意事项】和【药代动力学】）。
硝苯地平缓释片（Ⅰ）、硝苯地平缓释片（Ⅱ）、硝苯地平缓释片（Ⅲ）：
1、请按医生处方服用本品，否则将难于达到最佳治疗效果。
2、给药剂量应个体化，应基于疾病的严重程度及患者对药物反应情况。
3、根据患者的临床症状，逐步建立标准的给药方案。
4、肝功能损害的患者，应严密监测肝功能应降低给药剂量。
5、严重脑血管疾病患者应接受低剂量治疗。
6、除非有其他的处方指导，建议本品的用药剂量如下：
成人：标准给药剂量
（1）慢性稳定型心绞痛（劳累型心绞痛）：每日2次，每次2片或4片（相当于每日服用硝苯地平40mg）。
（2）血管痉挛型心绞痛（Prinzmetal’s心绞痛、变异型心绞痛）：每日2次，每次2片或4片（相当于每日服用硝苯地平40mg）。标准给药剂量为每日2次，每次20mg；剂量可增加道每日2次，每次40mg。
（3）原发性高血压：每日2次，每次2片或4片（相当于每日服用硝苯地平40mg）。标准给药剂量为每日2次，每次20mg；剂量可增加道每日2次，每次40mg。
7、给药方法：
（1）本品应饭后整片用水送服。
（2）若与食物同服可延缓但不减少本品的吸收。
（3）两次给药间隔不少于4小时。
（4）应逐步停止使用本品，尤其在用药剂量较高的情况下。
硝苯地平缓释胶囊：
口服，通常每12小时服一粒（20mg），一日二次，必要时剂量可增加至每12小时服两粒。本品服用时应用适量的水整粒吞服。
临床应用及指南
1、刘文姬通过硫酸镁与硝苯地平联合应用于妊娠期高血压疾病患者中的效果研究，得出结论对妊娠期高血压疾病患者采用硫酸镁与硝苯地平联合治疗的效果明显，且不良反应发生率较小，值得在临床中推广应用。（心电图杂志(电子版)，2019，8(04):52-53.）
2、李明子、白萍通过硝苯地平联合氢氯噻嗪对高血压患者的治疗效果观察，得出结论对高血压患者采取硝苯地平联合氢氯噻嗪治疗，治疗效果显著。（当代医学，2019(30):141-142[2019-11-13].）
3、杨丽通过硝苯地平缓释片对高血压治疗的临床疗效观察，得出结论硝苯地平缓释片治疗高血压患者

具有突出效果，可有效降低血压水平，促使患者血压维持正常水平。（全科口腔医学电子杂志，2019，6(31):177+182.）

4、李小菊、杨洛珍通过硫酸镁联合硝苯地平治疗子痫前期的临床效果，得出结论硫酸镁联合硝苯地平治疗子痫前期的临床效果显著，可以有效降低患者的血压水平，改善母婴结局，减少不良反应，值得推广应用。（临床医学研究与实践，2019，4(29):103-105.）

不良反应

1、尤其在治疗开始时，常见下列症状，但通常是瞬时的；头疼、面红和/或皮肤发红并伴有热感（红斑）、上下肢红肿、疼痛（肢红痛）。

2、偶有脉搏加快（心动过速）、心悸及因血管扩张引起的下肢水肿。偶见头晕及疲劳。也偶有上下肢麻刺感及血压将至正常值以下（低血压反应）的报道。

3、罕见胃肠功能絮乱（如：恶心、腹胀及腹泻）。

4、罕见皮肤变态反应（如；瘙痒、荨麻疹及皮疹）。

5、罕见血常规异常（如：红细胞、白细胞及血小板数降低，以及血小板减少引起的皮肤及粘膜出血）。

6、在接受长期治疗的患者中，罕见牙龈增生，停药后该症状自行消失。

7、极罕见肝功能异常（肝内胆汁郁积、转氨酶升高）、血细胞降低（粒细胞缺乏症）、皮肤及粘膜出血点（紫癜）、剥脱性皮炎、光照性皮炎以及急性全身性变态反应（如：皮肤及粘膜肿胀、喉头水肿、支气管肌肉痉挛，包括致命性呼吸窘迫），这些反应将在停药后消失。

8、罕见乳房肿胀（男子女性型乳房），尤其是长期接受本品治疗的老年男性患者，停药后该症状自行消失。

9、罕见血糖升高，该反应通常出现在糖尿病患者中。

10、在服用高剂量的患者中，个别出现肌肉疼痛、手指震颤以及轻微的一过性视力改变。

11、在刚开始接受治疗时，罕见患者由于血压降低出现短暂的意识丧失（昏厥）。

12、在刚开始接受治疗时，罕见患者发生心绞痛发作；若患者有心绞痛病史，心绞痛发生的频率、持续的时间及严重程度会有所增加。

13、肾功能不全患者在接受本品治疗时，可能会出现一过性肾功能恶化。

14、应特别注意高血压伴低血容量的透析患者，由于血管扩张可能会导致血压的明显降低。

15、在接受治疗的第一周，尿量会较前有所增加。

16、如果患者在接受治疗的过程中发现有本说明书中未记载的不良反应，请即刻向医生咨询。

禁忌

1、对硝苯地平及本品中其他成分过敏者。

2、曾出现过心源性休克。

3、重度主动脉瓣狭窄（主动脉（瓣）狭窄）。

4、不稳定型心绞痛。

5、近期心肌梗塞（最近4周内）。

6、正在服用利福平的患者。

7、孕妇禁用。

注意事项

1、对于心力衰竭及严重主动脉瓣狭窄的患者，当血压很低时(收缩压<90mmHg的严重低血压)，服用本品，应十分慎重。

2、本品有不可变形的物质，因此胃肠道严重狭窄的患者使用本品时应慎重，因为有可能发生梗阻的症状。胃结石的发生非常罕见，如果发生则可能需要手术治疗。

3、曾有个案报道，无胃肠道疾患的患者，出现梗阻症状。

4、行X线钡餐造影时，本品可引起假阳性结果（因充盈缺损，而被误认为息肉）。

5、基于ChildPugh评分的轻度、中度或重度肝功能损害患者用药应仔细监控，可能需要减少剂量。未在重度肝功能损害患者中研究硝苯地平的药代动力学（见【用法用量】和【药代动力学】）。因此，重度肝功能损害患者应慎用硝苯地平。
6、硝苯地平通过细胞色素P4503A4系统代谢消除。因此对细胞色素P4503A4系统有抑制或诱导作用的药物可能改变硝苯地平的首过效应或清除率（详见【药物相互作用】）。因此细胞色素P4503A4系统的弱效至中效抑制剂可能使硝苯地平的血浆浓度增加，例如：
（1）大环内酯类抗生素（例如红霉素）。
（2）抗-HIV蛋白酶抑制剂（例如利托那韦）。
（3）吡咯类抗真菌药（例如酮康唑）。
（4）抗抑郁药奈法唑酮和氟西汀。
（5）奎奴普丁/达福普汀。
（6）丙戊酸。
（7）西咪替丁。
硝苯地平与上述药物联合应用时，应监测血压，如有必要，应考虑减少硝苯地平的服用剂量。
7、对驾驶及操作机器能力的影响：对药物的反应因人而异，因此有可能影响驾驶及操作机器的能力，这种作用在治疗初期、更换药物及饮酒时尤其明显。
8、本品有不可吸收的外壳，这样可使药品缓慢释放进入人体内吸收。当这一过程结束时，完整的空药片可在粪便中发现。
9、硝苯地平控释片含有光敏性的活性成份，因此本品应避光保存。药片应防潮，从铝塑板中取出后应立即服用。
10、孕妇及哺乳期妇女用药：
（1）孕妇及生殖力：
①怀孕20周以内的孕妇禁用。对于孕妇尚无足够的研究。动物试验显示有胚胎毒性、胎仔毒性及致畸性。
②虽然有报道围产期窒息、剖腹产、早产和宫内生长迟缓的发生有所增加，但现有的临床证据未显示有特殊的产前风险。尚不清楚这些报道是否由潜在的高血压及其治疗或特殊的药物作用引起。
③现有的信息尚不足以排除本品对胎儿和新生儿的不良影响。因此怀孕20周以上的妇女使用本品时应仔细权衡利弊，仅在其它治疗方法不适用或无效时才考虑应用本品。
④妊娠妇女给予硝苯地平并同时静注硫酸镁时，由于血压可能过低而影响母亲和胎儿，故应密切监测血压。
⑤个别体外受精的案例中，硝苯地平类钙离子拮抗剂与精子头部的可逆性生化改变有关，从而损伤精子的功能。那些反复进行体外受精不成功的男性，在无其它原因可寻时，应考虑到硝苯地平类钙离子拮抗剂可能是其原因。
（2）哺乳期妇女：硝苯地平能进入母乳。因为尚无对婴儿可能产生何种影响的报告，所以哺乳期间必须服用硝苯地平时，首先要停止哺乳。
11、儿童用药：尚无儿童用药的安全性和有效性资料。
12、老年用药：尚无本品用于老年患者的资料。
13、药物过量：
（1）症状：
发生严重的硝苯地平中毒时可见下述症状：意识障碍甚至昏迷，血压下降，心动过速/心动过缓性心律失常，高血糖，代谢性酸中毒，低氧血症，心源性休克伴肺水肿。
（2）成人过量后的救治措施：
①在针对硝苯地平过量的救治中，应首先考虑到活性成分的排除及恢复心血管状态的稳定。
②给予洗胃后，如必要可给予小肠灌肠，尤其在处理本品和类似产品（如其它缓释片）引起中毒情况

下应尽可能全面，包括灌肠，以防止活性成分的吸收。
③血液透析意义不大，因为透析不能排除硝苯地平，但可进行血浆置换（高血浆蛋白结合，相对低的分布容积）。
④心动过缓性心律失常可给予β-拟交感神经药物治疗，对于危及生命的心动过缓可安置临时心脏起搏器。
⑤由心源性休克和动脉扩张导致的低血压可给予钙制剂治疗（缓慢静推10%的葡萄糖酸钙10ml-20ml，必要时可重复)。血钙可达到正常上限或轻度升高，如果应用钙制剂后，血压升高不明显，应考虑给予拟交感神经性血管收缩剂，如多巴胺、去甲肾上腺素，剂量依据疗效而定。
⑥因为有心脏超负荷的危险，所以补液或补充血容量时应慎重。
药物相互作用
1、影响硝苯地平的药物：
硝苯地平通过位于肠粘膜和肝脏的细胞色素P4503A4系统代谢消除。因此对细胞色素P4503A4系统有抑制或诱导作用的药物可能改变硝苯地平的首过效应（口服后）或清除率。
硝苯地平与下列药物合用时应考虑相互作用的程度和持续时间：
（1）利福平：
①具有很强的诱导细胞色素P4503A4系统的作用，如与之合用，硝苯地平的生物利用度会降低而影响其疗效。因此硝苯地平禁止与利福平合用。
②硝苯地平与下列细胞色素P4503A4系统的弱效至中效抑制剂合用时应监测血压，如有必要应考虑减少硝苯地平的服用剂量。
（2）大环内酯类抗生素（例如红霉素）：
①目前尚未开展硝苯地平与大环内酯类抗生素相互作用的研究，已知某些大环内酯类抗生素可抑制细胞色素P4503A4介导的其它药物的代谢。因此尚不能排除与硝苯地平合用后可增加硝苯地平血药浓度的潜在作用。
②阿奇霉素虽在结构上属于大环内酯类抗生素，但对细胞色素P4503A4系统无抑制作用。
（3）抗-HIV蛋白酶抑制剂（例如利托那韦）：目前还未进行硝苯地平与抗-HIV蛋白酶抑制剂之间可能存在的药物相互作用的临床研究。已知这类药物可抑制细胞色素P4503A4系统。另外，此类药物在体外可抑制细胞色素P4503A4介导的硝苯地平的代谢。因此尚不能排除此类药物与硝苯地平同时使用时，由于首过效应降低和排除量减少引起的硝苯地平血药浓度升高的可能性。
（4）吡咯类抗真菌药（例如酮康唑）：目前还未进行硝苯地平与吡咯类抗真菌药相互作用的临床研究。已知此类药物可抑制细胞色素P4503A4系统。因此与硝苯地平同时口服时，尚不能排除因为首过效应降低而使硝苯地平生物利用度增加的可能性。
（5）氟西汀：目前还未进行硝苯地平与氟西汀之间可能存在的药物相互作用的临床研究。氟西汀在体外可抑制细胞色素P4503A4介导的硝苯地平的代谢。因此尚不能排除这两种药物同时使用时硝苯地平血药浓度升高的可能性。
（6）奈法唑酮：目前还未进行硝苯地平与奈法唑酮之间可能存在的药物相互作用的临床研究。已知奈法唑酮可抑制细胞色素P4503A4介导的其它药物的代谢。因此尚不能排除这两种药物同时使用时硝苯地平血药浓度升高的可能性。
（7）奎奴普丁/达福普汀：硝苯地平与奎奴普丁/达福普汀合用可导致硝苯地平血浆浓度升高。
（8）丙戊酸：目前尚未进行硝苯地平与丙戊酸是否有潜在相互作用的研究，但是因为丙戊酸可抑制酶的活性，从而导致与硝苯地平结构相似的钙离子通道阻滞剂尼莫地平的血浆浓度升高，因此不能排除二者合用可提高硝苯地平的血药浓度，从而提高了疗效。
（9）西咪替丁：此药可抑制细胞色素P4503A4系统，因此可升高硝苯地平的血浆浓度而加强抗高血压疗效。
（10）西沙必利：西沙必利与硝苯地平合用可使硝苯地平的血浆浓度升高。

（11）对细胞色素P4503A4系统有诱导作用的抗癫痫药物，例如苯妥英、卡马西平和苯巴比妥
①苯妥英可诱导细胞色素P4503A4系统。与苯妥英合用时，硝苯地平的生物利用度降低从而导致疗效下降。当两种药物合用时，需监测硝苯地平的临床疗效，必要时需增加硝苯地平的剂量。如两种药物合用时已经增加了硝苯地平的剂量，停用苯妥英后应考虑减小硝苯地平的剂量。
②目前尚未进行硝苯地平与卡马西平或苯巴比妥是否有潜在相互作用的研究，但是因为卡马西平和苯巴比妥均可诱导酶的活性，从而导致与硝苯地平结构相似的钙离子通道阻滞剂尼莫地平的血药浓度降低，因此不能排除硝苯地平与卡马西平或苯巴比妥合用可降低硝苯地平的血药浓度，从而降低疗效。
2、受硝苯地平影响的药物：
（1）降压药：
①硝苯地平与其它降压药合用会加强硝苯地平的降压作用，例如：利尿剂、β-受体阻滞剂、ACE抑制剂、血管紧张素II受体拮抗剂、其它钙拮抗剂、α-肾上腺素阻滞剂、PDE5抑制剂、α-甲基多巴。
②硝苯地平与β-受体阻滞剂同时使用时，因为已知个别病例有心衰恶化的情况，必须对患者严格监测。
（2）地高辛：
与硝苯地平同时使用时会导致地高辛清除率降低，从而增加了地高辛的血药浓度。因此应监测其血药浓度防止药物过量，必要时可根据地高辛血药浓度减少其用药剂量。
（3）奎尼丁：
①硝苯地平与奎尼丁同时服用时，奎尼丁浓度下降，或停服硝苯地平后，在个别的病例中奎尼丁的血药浓度明显升高。因此服用奎尼丁时，若加服或停服硝苯地平均应监测血浆中奎尼丁的浓度，必要时可遵医嘱调整剂量。一些作者报道，硝苯地平与奎尼丁合用时硝苯地平的血浆浓度增加，然而另外一些作者则报道未发现硝苯地平的药代动力学变化。
②因此，如果已服硝苯地平的患者服用奎尼丁，则应密切监测血压，如有必要可降低硝苯地平的剂量。
（4）他克莫司：
通过细胞色素P4503A4系统代谢。已发表的资料显示，与硝苯地平合用时，个别病例需降低他克莫司的剂量。两药合用时应监测他克莫司的血药浓度，必要时降低他克莫司的用药剂量。
3、药物－食物相互作用：
葡萄柚汁：
可抑制细胞色素P4503A4系统。如与硝苯地平合用由于首过效应降低或清除率降低可使硝苯地平的血药浓度升高并延长硝苯地平的作用时间，从而增强降压的作用。经常服用葡萄柚汁者，末次服用后，这种效果可以持续至少3天。因此服用硝苯地平时应避免食用葡萄柚/葡萄柚汁。
4、不存在相互作用：
（1）硝苯地平与苯那普利、多沙唑嗪、奥利司他、泮托拉唑、雷尼替丁、他林洛尔、氨苯喋啶、氢氯噻嗪合用对硝苯地平的药代动力学没有影响。
（2）阿义马林：硝苯地平与阿义马林合用对阿义马林的代谢没有影响。
（3）阿司匹林：硝苯地平与100mg阿司匹林合用，对硝苯地平的药代动力学没有影响，同时，二者合用也不影响100mg阿司匹林对血小板聚集及出血时间的作用。
（4）异喹胍：硝苯地平与异喹胍合用对异喹胍的代谢率没有影响。
（5）坎地沙坦：硝苯地平与坎地沙坦合用，对二者的药代动力学均无影响。
（6）厄贝沙坦：硝苯地平与厄贝沙坦合用对厄贝沙坦的药代动力学没有影响。
（7）硝苯地平与奥美拉唑、罗格列酮合用对硝苯地平的药代动力学没有临床相关的影响。
5、其他形式的相互作用：
硝苯地平可导致尿香草扁桃酸的分光光度值假性升高，但HPLC测定不受影响。
药理作用

1、硝苯地平是1，4-二氢吡啶类钙离子拮抗剂。钙离子拮抗剂能减少钙离子经过慢钙通道进入细胞。硝苯地平特异性作用于心肌细胞、冠状动脉以及外周阻力血管的平滑肌细胞。
2、硝苯地平能扩张冠状动脉，尤其是大血管，甚至能扩张不完全阻塞区的健全血管。硝苯地平还可降低冠状动脉平滑肌的张力，防止血管痉挛。最终增加狭窄血管的血流量，提高供氧量。同时，硝苯地平由于降低了外周阻力（后负荷），而减少了氧需求。长期服用硝苯地平能防止新的冠状动脉粥样硬化病变的发生。
3、硝苯地平通过减少动脉平滑肌的张力而能降低已经增加了的外周阻力和血压。硝苯地平治疗初期可能出现短时的反射性心率加快而导致心输出量增加。但是这种增加不足以补偿血管的扩张。此外短期或长期服用硝苯地平都能增加钠和水的排出。对于高血压患者，硝苯地平的降压作用尤为显著。
4、一项追踪了3-4.8年、有6321例至少存在一个附加危险因子的高血压患者参加的多国、随机、双盲、前瞻性研究结果显示，硝苯地平控释片可减少心、脑血管事件的发生，与标准的利尿剂联合用药作用相当。
毒理作用
基于常规单剂量和多剂量的毒性、遗传毒性、致癌性的临床前资料显示，硝苯地平对人类无特殊危害。
1、长期毒性：犬每日口服按体重一次100mg/kg硝苯地平1年，未见毒性症状。在大鼠试验中，当饲料中药物浓度超过100ppm（约5-7mg/kg体重）时，动物出现了毒性反应。
2、致癌作用：大鼠口服硝苯地平2年，未见致癌作用。
3、致突变性：进行了鼠的Ames试验、微核和显性致死性试验。未发现硝苯地平有致突变性。
4、生殖毒性：
（1）硝苯地平对大鼠、小鼠和家兔可致畸，包括足趾异常、四肢畸形、腭裂、胸骨裂及肋骨畸形。足趾异常和四肢畸形可能是受损子宫出血的结果，但在器官形成后，服用硝苯地平的动物也观测到足趾异常和四肢畸形。
（2）硝苯地平给药后可伴随出现一些胚胎毒性、胎盘毒性和胎仔毒性作用，包括胎仔生长缓慢（大鼠，小鼠，家兔）、小胎盘和绒毛膜发育不全（猴）、胚胎和胎仔死亡（大鼠，小鼠，家兔）、孕期延长和新生幼崽生存率降低（大鼠，未对其它动物进行评估）。所有引起动物出现这些致畸作用、胚胎毒性作用和胎仔毒性作用的药物剂量是人体推荐最大剂量的数倍。
药代动力学
硝苯地平控释片：
本品在24小时内近似恒速释放硝苯地平，通过膜调控的推拉渗透泵原理，使药物以零级速率释放。它不受胃肠道蠕动和pH值的影响。服药后，药片中的非活性成份完整地通过胃肠道，并以不溶的外壳随粪便排出。
1、吸收：
（1）硝苯地平口服给药后几乎完全吸收。由于首过效应，即缓释型硝苯地平胶囊口服给药后的生物利用度为45-56%。稳态时硝苯地平控释片的生物利用度相当于硝苯地平胶囊的68-86%。进食时服药轻微影响药物的早期吸收率，但不影响生物利用度的范围。
（2）硝苯地平控释片给药后血浆药物浓度按控制速率升高，首次给药后6-12小时达到高值稳定水平。多剂量给药后相对恒定的血药浓度得到维持，给药期间24小时内血药浓度的峰谷波动很小（0.9-1.2）。
2、分布：硝苯地平与血浆蛋白（白蛋白）的结合率大约是95%。硝苯地平静脉注射后的分布半衰期为5-6分钟。
3、生物转化：
（2）口服给药后，硝苯地平主要通过氧化作用在肠壁和肝脏代谢。其代谢物无药物活性。
（2）硝苯地平绝大多数以代谢物形式经肾脏排泄，另有大约5-15%经由胆汁排泄到粪便中。尿中仅有

微量原形药物（0.1%以下）。
4、消除：
（1）常规剂型硝苯地平（硝苯地平胶囊）的终末消除半衰期为1.7-3.4小时。因为控释片释药和吸收过程中血浆药物浓度呈平台样，所以硝苯地平控释片给药后的终末消除半衰期这一药代动力学参数没有实际意义。硝苯地平控释片末次给药后，血浆药物浓度逐渐降低，消除半衰期与常规剂型相同。
（2）与健康志愿者比较，肾功能低下患者服药后药物消除无明显改变。
（3）一项比较轻度（ChildPughA）或中度（ChildPughB）肝功能损害患者与肝功能正常患者的硝苯地平药代动力学的研究显示，硝苯地平口服清除率平均下降了48％（ChildPughA）和72％（ChildPughB）。相应地，与肝功能正常的患者相比，硝苯地平AUC和Cmax分别平均增加了93％和64％（ChildPughA）、253％和171％（ChildPughB）。未在重度肝功能损害患者中研究硝苯地平的药代动力学（见【注意事项】）。
硝苯地平滴丸：
口服后吸收迅速、完全。口服后10分钟即可测出其血药浓度，约30分钟后达血药峰浓度，嚼碎服或舌下含服达峰时间提前。硝苯地平在10-30mg，生物利用度和半衰期无显著差别。吞服、嚼碎服或舌下含服硝苯地平片，相对生物利用度基本无差异。硝苯地平与血浆蛋白高度结合，约为90%。口服15分钟起效，1-2小时作用达高峰，作用持续4-8小时；舌下给药2-3分钟起效，20分钟达高峰。T1/2呈双相，T1/2β2.5-3小时，T1/2β为5小时。药物在肝脏内转换为无活性的代谢产物，约80%经肾排泄，20%随粪便排出。肝肾功能不全的患者，硝苯地平代谢和排泄速率降低。
贮藏方法
遮光，密封保存。
有效期
执行标准
硝苯地平片、硝苯地平软胶囊：中国药典2015年版二部。
硝苯地平控释片：进口药品注册标准JX20000463，JX20000464。
硝苯地平缓释片、硝苯地平缓释片（Ⅰ）：国家食品药品监督管理局国家药品标准WS1-（X-056）-2004Z。
硝苯地平缓释片（Ⅱ）：国家食品药品监督管理局国家药品标准WS3-（X-058）-2004Z。
硝苯地平缓释片（Ⅲ）：国家食品药品监督管理局国家药品标准YBH03952013。
硝苯地平缓释胶囊：国家食品药品监督管理局国家药品标准WS-634（X-502）-98（试行）。
硝苯地平滴丸：国家食品药品监督管理局国家药品标准YBH06032010。